



COMPRENDERE LA DISABILITÀ E LA SINDROME DI ReNU

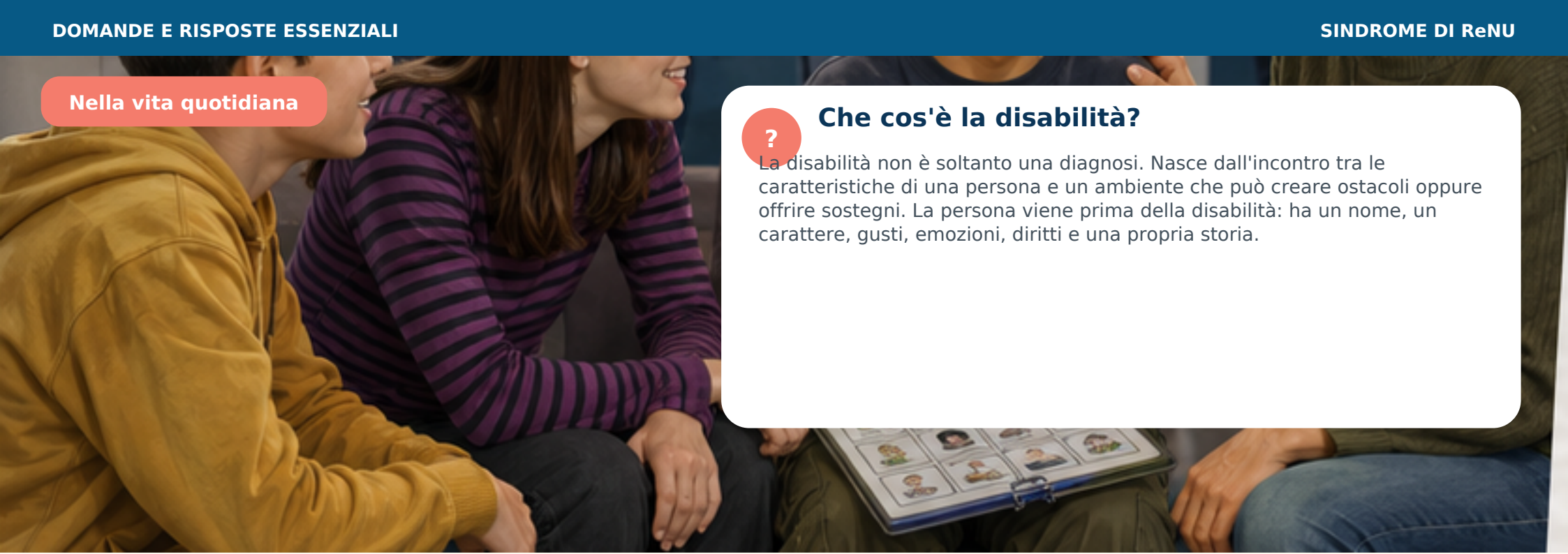
La diagnosi aiuta a conoscere i bisogni, ma non racconta tutta la persona.

Ogni individuo ReNU ha un nome, una personalità e un proprio modo di comunicare.

Le autonomie possono essere limitate e la comunicazione può essere più lenta.

Il compito degli adulti è ridurre gli ostacoli, offrire sostegni e costruire partecipazione.

**Prima della diagnosi c'è un nome.
Prima del bisogno c'è una persona.**

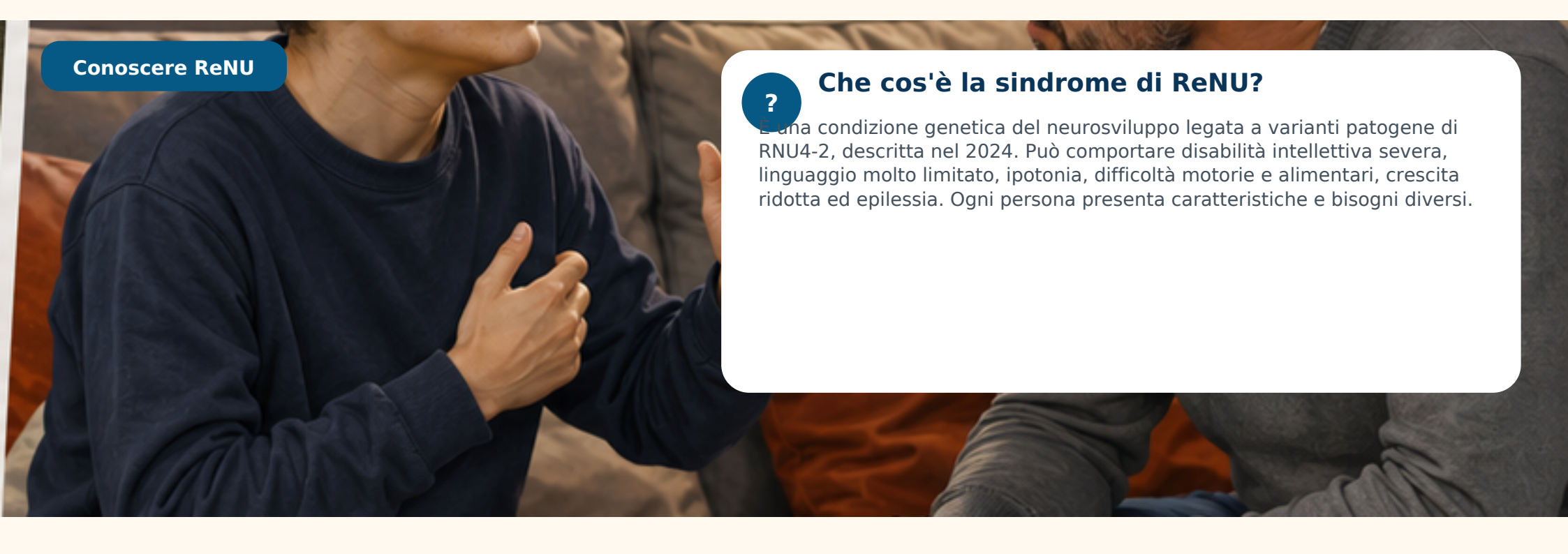


Nella vita quotidiana

?

Che cos'è la disabilità?

La disabilità non è soltanto una diagnosi. Nasce dall'incontro tra le caratteristiche di una persona e un ambiente che può creare ostacoli oppure offrire sostegni. La persona viene prima della disabilità: ha un nome, un carattere, gusti, emozioni, diritti e una propria storia.



Conoscere ReNU

?

Che cos'è la sindrome di ReNU?

È una condizione genetica del neurosviluppo legata a varianti patogene di RNU4-2, descritta nel 2024. Può comportare disabilità intellettiva severa, linguaggio molto limitato, ipotonia, difficoltà motorie e alimentari, crescita ridotta ed epilessia. Ogni persona presenta caratteristiche e bisogni diversi.

Osservare le capacità

?

Cosa significa disabilità intellettiva severa?

Significa che apprendere, comprendere situazioni nuove, comunicare e svolgere molte autonomie richiede tempi lunghi e sostegni importanti. Non significa assenza di comprensione, emozioni o capacità. Bisogna osservare ciò che la persona sa fare e come esprime le proprie scelte.

Comunicare

?

Come comunica una persona ReNU?

Possono comunicare con sguardo, gesti, espressioni, vocalizzi, una vocale, poche parole, immagini, CAA o comunicatore. Alcuni usano molto bene telefoni e tablet. Parlare con frasi brevi, aspettare e riconoscere ogni risposta permette una comunicazione autentica.

Dare tempo

?

Perché sembra non ascoltare o rifiutare una richiesta?

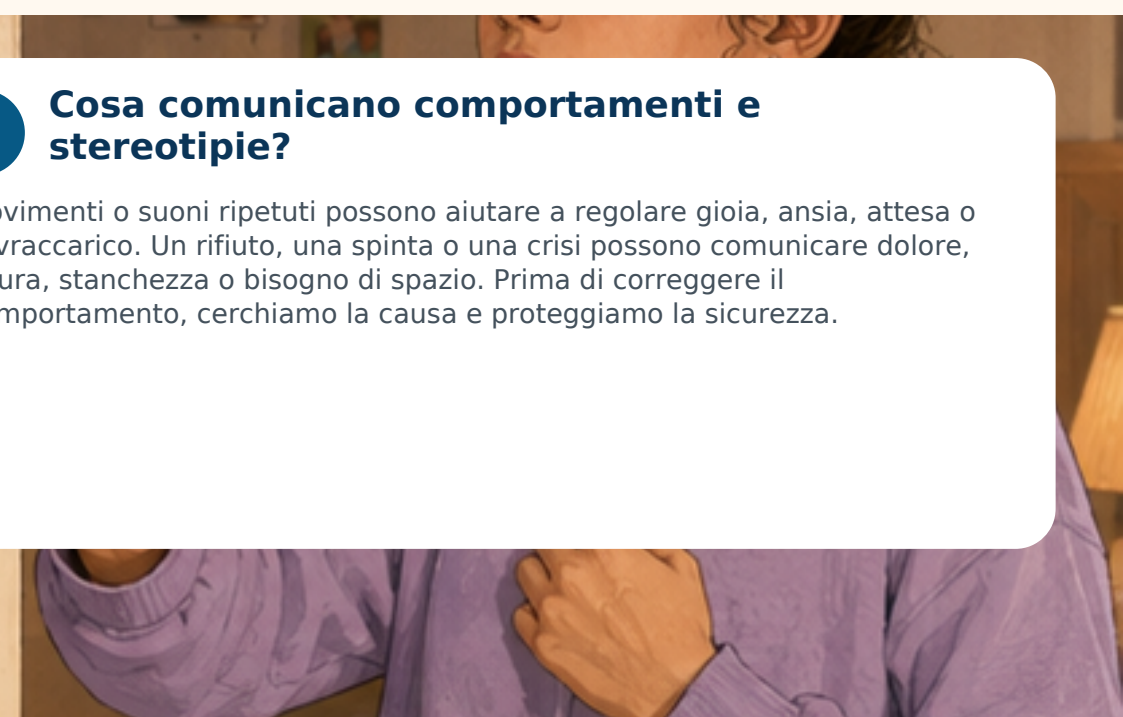
Può aver bisogno di più tempo per capire, elaborare e organizzare una risposta. Ripetere subito, alzare la voce o aggiungere molte parole può aumentare la difficoltà. Date una richiesta alla volta, mostratela con un gesto o un'immagine e lasciate un tempo reale di attesa.

Comprendere i segnali

?

Cosa comunicano comportamenti e stereotipie?

Movimenti o suoni ripetuti possono aiutare a regolare gioia, ansia, attesa o sovraccarico. Un rifiuto, una spinta o una crisi possono comunicare dolore, paura, stanchezza o bisogno di spazio. Prima di correggere il comportamento, cerchiamo la causa e proteggiamo la sicurezza.



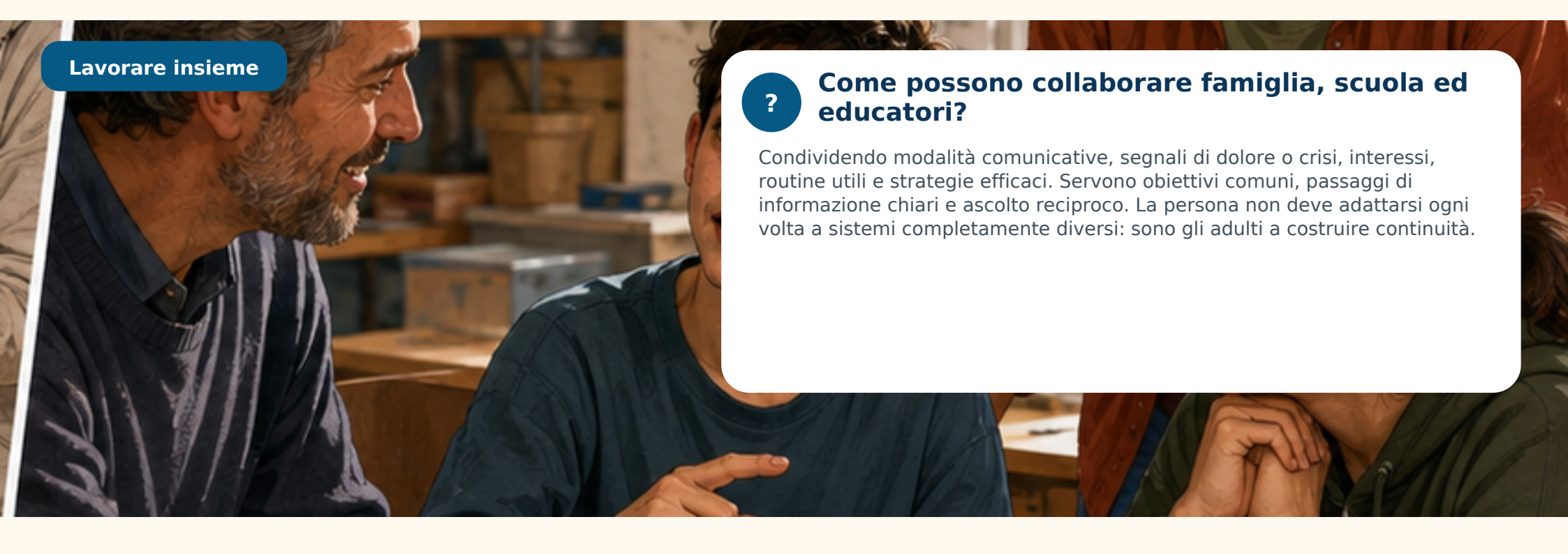
A young man with curly brown hair wearing a green hoodie and a young woman with long brown hair in a ponytail wearing a purple sweatshirt are smiling and talking. The woman is holding a ukulele. They are in a workshop with other people in the background.

Sostenere le scelte

?

Come si sostiene l'autonomia senza lasciare sola la persona?

Offriamo scelte concrete e accessibili, rispettando il suo modo di rispondere. Adattare un'attività non significa fare tutto al suo posto. L'obiettivo è permetterle di partecipare, decidere quando possibile e ricevere l'aiuto necessario senza essere infantilizzata.

A man with a beard and grey hair wearing a blue and white striped shirt is smiling and talking to a young man with dark hair wearing a blue t-shirt. They are in a workshop with wooden tables and tools in the background.

Lavorare insieme

?

Come possono collaborare famiglia, scuola ed educatori?

Condividendo modalità comunicative, segnali di dolore o crisi, interessi, routine utili e strategie efficaci. Servono obiettivi comuni, passaggi di informazione chiari e ascolto reciproco. La persona non deve adattarsi ogni volta a sistemi completamente diversi: sono gli adulti a costruire continuità.



CONOSCERE PER COMPRENDERE, COLLABORARE E INCLUDERE

Nessun adulto possiede da solo tutte le risposte.

Famiglia, scuola, educatori e professionisti costruiscono insieme sostegni coerenti.

La persona non è il problema da risolvere: è la voce da ascoltare.

Fonti essenziali: GeneReviews, RNU4-2-Related Neurodevelopmental Disorder (2026); Chen et al., Nature (2024); Greene et al., Nature Medicine (2024).

LA RICERCA OGGI, LA CURA DOMANI